

09 - 01- Les tumeurs de l'oesophage - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui s'intitule les tumeurs de l'osophage. Les tumeurs de l'osophage sont dominées par le cancer de l'osophage. Bien que peu fréquente, représentant moins de 1% de tous les cancers et près de 6% des cancers digestifs, le cancer de l'osophage est important à étudier.

En effet, il est caractérisé par un très mauvais pronostic. Dans les cancers de l'osophage, deux tumeurs principales sont à connaître. D'abord le carcino-épidermoïde, largement le plus fréquent, représentant près de 90% des cancers de l'osophage.

Et en second lieu l'adénocarcénium qui est en progression, notamment dans les pays occidentaux. Plusieurs facteurs de risque sont reconnus pour leur rôle dans le développement du cancer de l'osophage. Il s'agit notamment du tabac, de l'alcool et de l'ingestion de boissons chaudes, notamment du thé, dans certaines communautés.

Certains syndromes sont aussi suspectés de favoriser le développement du cancer de l'osophage, notamment l'osophage de Barrette pour l'adénocarcinome. Concernant le site de développement du cancer de l'osophage, un élément capital est à connaître. Si pour le carcino-épidermoïde, on peut le retrouver dans la totalité de l'osophage, le tiers supérieur, le tiers moyen ou le tiers inférieur, l'adénocarcinome est presque exclusivement retrouvé au niveau du tiers distal de l'osophage.

Concernant les rappels anatomiques, l'osophage est un tube reliant l'oropharynx à l'estomac. Il est composé de plusieurs portions, cervicales, thoraciques et une courte portion sous-diaphragmatique. A la partie inférieure, l'osophage s'abouche dans l'estomac.

Macroscopiquement, la muqueuse oesophagienne tranche nettement avec la muqueuse gastrique. Sa couleur blanc nacré est facilement reconnaissable. Sur le plan histologique, la paroi oesophagienne est composée d'une muqueuse formée par l'épithélium, le chorion et la musculaire muqueuse, d'une sous-muqueuse, d'une musculature avec deux couches, interne et externe, et en périphérie, la paroi oesophagienne est composée d'une adventice qui est un tissu conjonctif lâche.

L'élément capital à assimiler dans ce rappel histologique est l'absence pour la paroi oesophagienne de séreuse. La séreuse, composée de cellules jointives, est considérée comme une barrière naturelle dans les organes qui en disposent contre l'extension tumorale. Son remplacement par une adventice dans l'osophage explique donc en partie le mauvais pronostic de ce cancer, car il est beaucoup plus facilement extensible vers les organes de voisinage.

Ici, nous observons l'épithélium malpighien normal non kératinisé de l'osophage, et sur l'autre photo, la jonction entre l'osophage avec son épithélium malpighien non kératinisé et l'estomac avec son épithélium glandulaire. En pathologie oesophagienne, l'examen endoscopique représente un examen phare. Il permet la visualisation des lésions des tumeurs et la

visualisation des muqueuses œsophagiennes et gastriques.

La limite entre ces deux muqueuses œsophagiennes et gastriques est appelée la ligne Z. Sur le plan endoscopique, la muqueuse malpighienne apparaît blanc, nacré, et la muqueuse gastrique glandulaire apparaît rosée. L'une des anomalies qui sont recherchées particulièrement en endoscopie, c'est la montée de la muqueuse gastrique au-delà de la ligne Z. Cet aspect particulier est appelé l'endobrachiosophage. Les tumeurs de l'œsophage peuvent se manifester par des symptômes cliniques divers.

Brûlure de l'œsophage, douleur rétrosternale, blocage alimentaire, voire dysphagie. En pathologie œsophagienne, le diagnostic est souvent tardif. Cela accentue encore plus le mauvais pronostic des tumeurs de l'œsophage.

Devant une de ces symptomatologies, une endoscopie avec biopsie systématique est obligatoire. Le diagnostic anatomopathologique des tumeurs de l'œsophage peut se faire sur un prélèvement cytologique, une mucosectomie qui est un prélèvement superficiel de la muqueuse œsophagienne, une œsophagectomie ou une œsogastrectomie emportant l'œsophage et une partie de l'estomac. Le prélèvement cytologique par brossage de la tumeur est un examen peu spécifique.

Il est plutôt orienté sur le dépistage et il n'a d'intérêt que s'il est positif. En cas de tumeur superficielle, la mucosectomie peut paraître un choix judicieux. Il se fait en emportant la muqueuse de l'œsophage après délimitation de la lésion, séparation de la muqueuse et de la musculaire par une injection du sérum physiologique dans la sous-muqueuse, puis résection de la lésion avec une marge de muqueuse saine.

Le prélèvement intéresse donc la muqueuse et la sous-muqueuse. Elle doit être adressée épinglée sur du liège et orientée. La muqueuse a un but curatif avec un examen anatomopathologique de la pièce obligatoire.

Elle est réservée aux seules tumeurs superficielles dites T1 et N0, donc n'infiltrant pas la musculature et sans atteinte ganglionnaire. Pour s'assurer du caractère superficiel de la tumeur, un bilan complet est réalisé avant le geste, et notamment l'écho-endoscopie. L'examen anatomopathologique précisera le type histologique, le grade de différenciation de la tumeur, la présence de facteurs histopronostiques, notamment la présence d'embolies, d'onglets de mésentérinerveux, le niveau d'infiltration de la tumeur dans la paroi et la qualité de l'exérèse périphérique, en pratique est-ce que les limites sont saines ou pas.

Le dernier matériel d'étude possible reste la pièce chirurgicale. Elle s'adresse aux patients qui sont opérables et surtout lorsque la lésion est résécable, donc non étendue aux organes de voisinage. En général, il s'agit d'une œsophagectomie transthoracique subtotale avec curage ganglionnaire et plastique astringue.

Ce geste chirurgical doit emporter au moins 6 ganglions médiastinaux. Elle est adressée au

examen au laboratoire d'anatomie pathologique. L'examen anatomopathologique doit préciser le type de la pièce opératoire, la localisation de la tumeur, le type histologique, le degré de différenciation.

Si un traitement néoadjuvant a été donné au patient, la réponse thérapeutique, le niveau d'infiltration de la tumeur dans la paroi, le T, l'état des ganglions régionaux, la présence ou non d'embole vasculaire, la présence ou non d'engainement périnerveux, la qualité des xérès avec les marges, saines ou pas, et enfin un stade PTNM en précisant l'année et la classification utilisée. En pratique, on préfère recevoir la pièce fraîche, pouvoir l'ouvrir, bien l'étaler et l'épingler. Après fixation, des prélèvements sont effectués au niveau de la lésion, de la muqueuse oesophagienne, si l'estomac est parvenu avec la pièce, il est aussi prélevé, et les limites inférieures et supérieures.

Nous allons étudier maintenant les principales tumeurs épithéliales de l'oesophage. La première tumeur à étudier est le papillom. Il s'agit d'une prolifération polypoïde tapissée par un revêtement de type malpiedien.

Elle est peu fréquente, le plus souvent solitaire, de découvertes fortuites. Elle touche principalement le bas oesophage, l'homme de plus de 40 ans. L'une des causes les plus connues est l'infection par l'HPV.

Elle n'est pas considérée comme une lésion précancéreuse, une simple excision et le traitement à adopter. Macroscopiquement, elle se manifeste par une masse cécile, blanchâtre ou rose, de maximum 5 mm de diamètre. Microscopiquement, le papillom se manifeste par une lésion bourgeonnante dite exophytique, parfois endophytique.

Cette lésion est tapissée par un épithélium qui est malpiedien, hyperplasique, avec un stroma qui est fin, fibrovasculaire. L'élément clé pour le diagnostic est la mise en évidence de caïrocyte, paracératose ou cellules binucléées stigmates de l'infection par l'HPV. Autre tumeur épithéliale bénigne important à connaître est l'adénome.

Il s'agit d'une prolifération bénigne de glandes de la sous-muqueuse qui vont bomber en macroscopie sur la muqueuse oesophagienne. Attention à ne pas prendre cette tumeur pour une tumeur épithéliale. Le diagnostic se fait par le myopsie de la tumeur.

Concernant les tumeurs malignes de l'oesophage, le carcinome épidermoïde représente la tumeur la plus fréquente. C'est une tumeur qui peut siéger sur toute la hauteur de l'oesophage. Elle est présente comme facteur de risque, notamment le tabac et l'alcool.

Ces deux facteurs de risque sont associés avec des cancers horaires. Autre facteur de risque, l'ingestion de boissons brûlantes et l'infection par l'HPV. Concernant le carcinome épidermoïde, La lésion précancéreuse est appelée dysplasie épithéliale malpighienne.

La séquence normale du cancer dans le carcinome épidermoïde commence par une dysplasie de bas grade, puis de haut grade, puis carcinome épidermoïde in situ, et enfin lorsqu'il y a une

infiltration du chorion sous-jacent carcinome épidermoïde infiltrant. En pratique, la distinction entre dysplasie de haut grade et carcinome épidermoïde in situ est très difficile. La séparation des degrés de dysplasie de bas grade et de haut grade se fait selon la sévérité des atypies cytonucléaires, elles sont plus sévères dans la dysplasie de haut grade, et le degré d'extension en hauteur dans l'épithélium de ces dysplasies.

S'agit-il de la moitié inférieure seulement, à ce moment-là c'est une dysplasie de bas grade, ou bien toute la hauteur de l'épithélium est concernée, et là on est dans une dysplasie de haut grade. Actuellement, le terme de dysplasie est plutôt remplacé par la néoplasie intraépithéliale de bas grade pour la dysplasie de bas grade, de haut grade pour la dysplasie de haut grade. Sur le plan endoscopique, la dysplasie apparaît comme une zone déprimée irrégulière.

L'utilisation du testolugol permet clairement de mettre en évidence la zone suspecte. La zone normale apparaît foncée, la zone anormale ici est non colorée. Le stade initial de l'infiltration de le carcinome épidermoïde est appelé la microinvasion.

Elle se caractérise par l'infiltration de petit amas ou de cellules isolées dans le chorion superficiel. En général, ces lésions de microinvasion s'associent à proximité dans l'épithélium de la présence de lésions de dysplasie de haut grade. Le diagnostic est souvent fortement suspecté déjà à l'endoscopie en mettant en évidence une masse bourgeonnante et sur la pièce opératoire avec notamment des lésions de sténosophagiennes, dilatation de l'osophage en amont, tumeurs bourgeonnantes voire végétantes avec des remaniements ulcérés et nécrotiques.

Voici les aspects macroscopiques du carcinome épidermoïde de l'osophage avec des tumeurs ulcérobourgeonnantes de tailles parfois différentes. On reconnaît aisément la muqueuse osophagienne par son aspect blanc nacré et la muqueuse glandulaire de l'estomac. Si on effectue un testolugol, la zone anormale est non colorée contrairement à la zone normale.

D'autres aspects macroscopiques du carcinome épidermoïde de l'osophage avec une tumeur exubérante, végétante ou un aspect sténosant de l'osophage. Sur le plan histologique, le carcinome épidermoïde en général est caractérisé par la présence de boyaux tumoraux ou de petites amas qui sont formés par des cellules jointives les uns des autres. La présence de globes cornés et de dyskératoses dénote du caractère différencié de la tumeur.

Leur absence, à l'opposé, caractérise un carcinome épidermoïde plutôt peu différencié. Certains aspects histologiques du carcinome épidermoïde allant d'aspects plutôt différenciés à d'autres beaucoup moins différenciés. En matière de carcinome épidermoïde de l'osophage, l'un des facteurs histopronostiques majeurs est la présence ou pas d'embolles vasculaires.

Ici nous voyons une paroi vasculaire avec du sang à l'intérieur et un petit embolle tumorale à l'intérieur. Un autre aspect et plein d'autres sur cette autre photo. Autre entité de tumeur épithéliale de l'osophage est le carcinome verrucueux.

Il s'agit d'un carcinome épidermoïde très bien différencié. La tumeur est en général bourgeonnante, dite en chou-fleur. Sur le plan histologique, la tumeur est très bien différenciée.

La véritable difficulté dans le diagnostic de ce carcinome vésiculeux revêt dans la mise en évidence de l'infiltration. Souvent de nombreuses recoupes du bloc tumoral sont nécessaires. Dans le versant opposé des tumeurs épithéliales de l'œsophage, le carcinome à cellules fusiformes est une tumeur plutôt peu différenciée.

Elle est souvent polypoïde à cheval sur le tiers moyen et inférieur. Sur le plan microscopique, on retrouve une composante malpighienne en général peu différenciée et une composante plutôt sarcomatoïde qui ressemble à un sarcome avec des cellules tumorales fusiformes. Parfois, cette composante fusiforme aboutit à la formation possible d'autres structures osseuses ou cartilagineuses.

Autre rareté dans les tumeurs épithéliales de l'œsophage, on retrouve le carcinome basaloïde. Sa particularité est surtout dans son siège inhabituel au niveau de l'œsophage. Le diagnostic est plutôt aisé par la reconnaissance en histologie de l'architecture basaloïde.

Nous entamons maintenant l'étude des tumeurs épithéliales d'origine glandulaire, donc l'adénocarcinome. Avant de parler de l'adénocarcinome, on va s'arrêter sur un facteur de risque principal de ce dernier, à savoir l'œsophage de Barrett. Ce dernier se définit par le remplacement de la muqueuse malpighienne distale de l'œsophage par un épithélium métaplasique spécialisé.

C'est une muqueuse glandulaire qui peut être soit gastrique, soit intestinale. En pratique, la muqueuse malpighienne distale au niveau de certains îlots va se transformer de la muqueuse malpighienne vers une muqueuse glandulaire. On appelle ainsi cette transformation œsophage de Barrett ou endobrachiosophage.

En général, cet état est une réponse de la muqueuse à une irritation chronique, principalement le reflux gastro-œsophagien. Cet œsophage de Barrett peut régresser après traitement. En pratique, 3 à 12% des patients présentant des reflux gastro-œsophagiens biopsiés présentent une muqueuse de Barrett.

Pourquoi cette transformation? Tout simplement parce que la muqueuse cylindrique est plutôt plus résistante aux acides, pepsines et biles qui refluent. En matière du diagnostic de l'œsophage de Barrett, deux points sont à connaître. Soit il s'agit d'une muqueuse glandulaire généralement gastrique d'apparence presque normale.

Celle-ci est plus ou moins continue avec l'estomac. Dans ce cas de figure, la question qui se pose s'agit-il vraiment d'une muqueuse métaplasique de l'œsophage ou bien un prélèvement qui a été fait dans l'estomac? Pour avoir la réponse, il faut d'abord s'aider du compte-rendu endoscopiste qui va spécifier notamment la distance à laquelle a été faite la biopsie. Et

deuxièmement, c'est l'étude de l'environnement qui est autour de cette muqueuse métaplasique.

S'il y a de la muqueuse oesophagienne autour, on peut supposer qu'il s'agit plutôt d'une muqueuse métaplasique. La deuxième possibilité est la présence d'une muqueuse plutôt intestinale au niveau de la biopsie. Là, il s'agit franchement d'une lésion qui est anormale.

Une muqueuse intestinale n'a pas à se retrouver normalement au niveau de l'oesophage. Cette situation est compliquée par le risque réel d'une dysplasie et du développement d'un adénocarcinome. Dans ce cas de figure, des endoscopies régulières avec prélèvements histologiques sont hautement nécessaires.

Si on prend le cas de figure le plus facile à diagnostiquer pour l'oesophage de Barad, c'est la mise en évidence d'une muqueuse glandulaire au-dessus de la ligne Z qui sépare l'oesophage de l'estomac. A l'histologie, on trouvera un épithélium intestinal, un épithélium qui ressemble au cardia plus ou moins, et surtout la présence de cellules qui sécrètent du mucus associées à des cellules antérocytaires intestinales. Dans le meilleur des cas, cette mise en évidence se fait sur un prélèvement fait au-delà de la ligne Z, à 3 ou 4 cm.

Dans ce cas de figure, le diagnostic est aisé, c'est bien un endobrachiosophage. En pratique, ce n'est pas toujours aussi aisé. On retrouve trois possibilités.

Soit un oesophage de Barad dit segment long, donc une métaplasie glandulaire qui s'étend sur plus de 3 cm. Ou un oesophage de Barad avec un segment court qui s'étend sur moins de 3 cm. Et le cas le plus difficile à diagnostiquer, segment ultra court sur moins de 1 cm.

Aspect endoscopique de l'oesophage de Barad avec une muqueuse glandulaire qui remonte plus ou moins haut, avec quelques îlots résiduels de muqueuse oesophagienne. Aspect macroscopique de l'oesophage de Barad avec une muqueuse oesophagienne reconnaissable par son aspect planchâtre. Muqueuse glandulaire gastrique par son aspect rosé.

Et on voit une montée de la muqueuse glandulaire qui empiète sur la muqueuse oesophagienne. Sur le plan histologique, muqueuse malpighienne de l'oesophage avec une muqueuse glandulaire à côté. Voir un aspect d'épithélium intestinal avec des cellules notamment antérocytaire et calicifère.

Aspect microscopique des dysplasies ou néoplasies intraépithéliales de bas grade et de haut grade dans l'oesophage de Barad. Remarquez un nombre beaucoup plus important des atypies au niveau de cette néoplasie intraépithéliale de haut grade. Pour le diagnostic de l'oesophage de Barad, il est préconisé de rechercher un aspect caractéristique, d'en faire la biopsie.

Au moins 8 biopsies qui seront traitées en anapathes par 4 niveaux de coupe. Au niveau du compte-rendu, on précisera le type d'épithélium retrouvé. Sur cet épithélium, la présence ou l'absence de dysplasie qui est annonciateur d'une évolution future vers l'adénocarcinome.

Cette dysplasie-ci est là, sans grade et sans étendue. La dysplasie associée à l'osophage de Barad peut aussi être appelée néoplasie intraépithéliale. La dysplasie intraépithéliale se base ici principalement sur les atypies.

La présence ou l'absence de noyaux stratifiés, hyperchromatiques, le rapport nucléocytoplasmique et la présence de mitose. En général, lorsqu'il y a une dysplasie ou une néoplasie intraépithéliale de haut grade, le risque d'adénocarcinome est beaucoup plus élevé. Surtout lorsqu'on a une atteinte qui est beaucoup plus importante.

Si elle est supérieure à 2 cm, en général, on estime que le risque est multiplié par 3. Donc, l'adénocarcinome qui est la tumeur épithéliale de l'osophage qui vient après le carcinome épidermoïde en matière de fréquence est une tumeur qui siège principalement dans le tiers inférieur de l'osophage parce qu'elle naît sur les lésions d'endobrachiosophage. Sa fréquence est en augmentation. La séquence normale du développement de l'adénocarcinome passe d'abord par une métaplasie intestinale au niveau de la muqueuse de l'osophage.

Cette métaplasie va développer une dysplasie de bas grade puis de haut grade avant d'aboutir à l'adénocarcinome infiltrant. En général, sur le plan macroscopique, l'adénocarcinome apparaît comme une tumeur bourgeonnante polypoïde avec une ulcération centrale. Elle se situe à proximité de la jonction oso-gastrique.

Vous remarquez la muqueuse normale de l'osophage, la muqueuse gastrique. Ici, la muqueuse glandulaire qui remonte au-delà de la ligne Z dans la muqueuse osophagienne et donc qui aboutit finalement au développement de l'adénocarcinome. Sur le plan histologique, il s'agit d'une prolifération tumorale qui est agencée en tubes et en glandes et structures qui ressemblent à des glandes d'un gland uniforme, d'où le terme d'adénocarcinome.

En général, cet adénocarcinome se retrouve à proximité de lésions d'ondes aux bras qui osophagent. Un autre aspect histologique, donc des glandes, associé à proximité d'un aspect d'ondes aux bras qui osophagent, diagnostique adénocarcinome. Toujours un aspect d'adénocarcinome en grossissement important.

On a des tubes ou des glandes avec des atypiques qui sont vraiment très très importantes, avec un aspect cytoplasmique foncé basophile et des noyaux qui sont très très irréguliers. Une fois le diagnostic anatomopathologique fait et le degré d'infiltration de la tumeur établi, on posera le diagnostic avec la classification PTNM. T pour la tumeur, N pour l'état ganglionnaire, M pour éventuellement la présence de métastases.

Donc le degré d'infiltration de la tumeur. Le PT1 lorsqu'on la tumeur infiltre. Le choréon, la musculaire muqueuse et la sous-muqueuse.

Le PT2, la musculuse. PT3, l'adventisse. PT4 lorsqu'elle atteint les organes de voisinage.

Il existe aussi une classification qui est surtout utilisée pour les tumeurs superficielles, donc qui n'atteignent pas la musculuse avec plusieurs niveaux. Sachez seulement que même s'il existe

une tumeur qui atteint que la sous-muqueuse profonde, malgré ça, cette tumeur peut être associée à la présence de ganglions régionaux métastatiques dans environ 30% des cas. Donc des tumeurs superficielles qu'on traitera préférentiellement par la muqueuse lectomie.

Mais attention, dans les tumeurs de la sous-muqueuse profonde, il y a un risque de développement de ganglions régionaux métastatiques. Après avoir longuement parlé des tumeurs épithéliales, nous passerons en revue beaucoup plus rapidement les tumeurs mésenchymateuses. La première tumeur que nous allons aborder est le léomuome.

C'est une tumeur bénigne, mésenchymateuse, qui va donner un aspect plutôt nodulaire, en macroscopie et en endoscopie, blanchâtre à la coupe, qui est bien limitée. C'est normal, c'est une tumeur bénigne. Sur le plan histologique, il s'agit d'une tumeur bien limitée, faite de faisceaux de fibres musculaires lisses qui sont enchevêtrés entre elles, donnant cet aspect caractéristique qu'on retrouve dans d'autres sites anatomiques.

Élément important, c'est une tumeur mésenchymateuse, la muqueuse en regard est en général indemne. C'est une tumeur qui bombe, qui repousse en haut, mais qui n'envahit pas la muqueuse. Autre tumeur particulière, cette fois, de l'osophage.

C'est ce qu'on appelle la tumeur à cellules granuleuses, ou la tumeur d'abricoseuf ou myoblastone. C'est le site, donc l'osophage est le site le plus important au niveau digestif. C'est la deuxième tumeur stromale la plus fréquente après le léomuome.

Elle touche la femme, vers la quatrième décennie. Elle se trouve plutôt dans le tiers inférieur et elle devient symptomatique lorsqu'elle est de grande taille. Notamment, elle va se manifester par une obstruction.

Sur le plan endoscopique et macroscopique, c'est une tumeur qui est plus souvent solitaire, couleur jaune, blanchâtre. Elle aussi est mésenchymateuse, donc l'épithélium est plutôt intact. Elle est mal limitée et sa taille est relativement petite, jusqu'à 2 cm.

Sur le plan microscopique, la tumeur à cellules granuleuses se caractérise par des nappes de cellules d'allure épithéliales, ressemblant aux cellules épithéliales. Ces cellules sont uniformes. Elle présente un cytoplasme qui est abondant et éosinophile, rose, granulaire.

Donc avec un aspect de petit grain au niveau du cytoplasme. On peut s'aider d'une coloration spéciale devant cet aspect cytoplasmique caractéristique. Et donc on utilisera la coloration PAS qui revient positive.

Le noyau de cellules est de petite taille. Attention, un élément qui peut fausser le diagnostic, c'est la présence d'une anomalie au niveau de l'épithélium en regard. On peut avoir une petite hyperplasie pseudoépithéliomateuse, c'est à dire un épithélium qui va être augmenté de taille et parfois de manière assez inquiétante.

Attention à ne pas partir sur un diagnostic de tumeur épithéliale alors que le diagnostic

concerne une tumeur mésenchymateuse. Cette tumeur siège en effet dans le corneau superficiel voire au niveau de la musculature. On peut s'aider pour le diagnostic de l'examen immunohistochimique.

Et on a à disposition pour ce faire 4 marqueurs, la PS1, l'inibine, le CD68 et la cholestérol. La tumeur à cellules granuleuses peut être maligne dans 3% des cas. 4 éléments vont nous aider à poser ce diagnostic de malignité.

Une croissance rapide supérieure à 4 cm. La présence de nécrose tumorale dans la tumeur. La présence d'une cellularité augmentée, c'est à dire un nombre de cellules qui est augmenté à l'examen histologique.

Et un index mitotique élevé avec présence de plus de 2 mitoses par champ microscopique. En images, les aspects microscopiques des tumeurs à cellules granuleuses. Avec une tumeur du corion, faite de cellules avec un noyau qui est granulaire et osinophile.

Noyau de petite taille et l'immunohistochimie positive par l'un des 4 marqueurs. Autre tumeur qu'on peut retrouver au niveau de l'osophage, c'est le lipome. C'est une tumeur de cellules adipeuses, une tumeur bénigne.

Prolifération bénigne, donne un aspect jaunâtre. Et sur l'histologie, c'est des adipocytes matures sur une tumeur bien limitée. Toujours dans les tumeurs mésenchymateuses, bénignes.

Les manches jaunes, concernent la composante vasculaire, donc une tumeur vasculaire. Composée de vaisseaux sanguins. Quand ces vaisseaux sanguins sont de grande taille, on l'appelle hémangiome caverne.

Voici l'aspect de l'hémangiome caverne. Sur la composante vasculaire concernée est un vaisseau lymphatique. La tumeur est dite lymphangiome.

Des vaisseaux lymphatiques remplis de sécrétions de la lymphe. Le diagnostic est celui d'un lymphangiome. Enfin, d'autres tumeurs exceptionnelles sont possibles.

Ici, un aspect macroscopique d'un mélanome au niveau de l'osophage. C'est plutôt une rareté, un cas exceptionnel. Mais le diagnostic histologique ne se différencie pas par rapport aux autres mélanomes d'autres localisations.

En conclusion, les tumeurs de l'osophage sont dominées par deux grands types histologiques. Le carcinome épidermoïde majoritaire et l'adénocarcinome qui progresse. Le carcinome épidermoïde peut être retrouvé sur la totalité de l'osophage.

L'adénocarcinome est lui plutôt retrouvé au niveau du tiers distal associé à des lésions de dysplasie sur l'osophage de Barrett. Particularité de l'osophage, la possibilité pour les lésions précoces d'utiliser la mycoscopia moyen diagnostique et thérapeutique. Les tumeurs de

l'osophage restent de mauvais pronostics expliqués par l'histologie et par le retard de dépistage.